Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

SUPSI

La disabilità nella storia

Evoluzione della visione della persona in situazione di handicap

Chiara Balerna, Michela Luraschi, Donatella Oggier-Fusi, Piercarla Reposo

Modulo: Percorsi nelle disabilità

L’antichità

- L’inizio della storia della disabilità è contemporaneo all’inizio della specie umana
- Non ci sono informazioni scritte, ma solo ipotesi degli storici. Non si deve quindi supporre di avere una ricostruzione esaustiva ma solo dei frammenti
- Le persone con un deficit grave sicuramente non sopravvivevano alla nascita
- Le persone che sopravvivevano ma con un deficit troppo importante per assumere un ruolo nelle tribù e resistere agli spostamenti imposti dal nomadismo venivano probabilmente eliminate
- Le persone con un deficit moderato avevano un ruolo in queste società meno complesse e meno centrate sugli aspetti intellettuali

- Nel 2009, in Spagna, nella Sierra de Atapuerca, sono stati ritrovati i resti di un giovane vissuto circa 530.000 anni fa, che presentava un grave ritardo nello sviluppo psico-fisico. Questo ritrovamento ha dimostrato che il giovane viveva all'interno della comunità e non era stato abbandonato a causa della sua disabilità. Potrebbe sembrare un esempio di inclusione primitiva, o almeno, così era stata interpretata la notizia. Tuttavia, i reperti ritrovati non permettono di ricostruire un quadro completo e dettagliato della vita di questo individuo all'interno della sua comunità, lasciando ignote le forme della sua quotidianità (Schianchi 2016).

Mesopotamia (1700-560 a.C.)

- I primi codici legali e l'inizio delle religioni rappresentano dei cambiamenti fondamentali nelle civiltà antiche.
- La disabilità era vista come una punizione divina o possessione da spiriti maligni, spiegata attraverso modelli causali magici. In tutte le società, antiche e moderne, esistono modalità culturali per reinterpretare situazioni negative, come la disabilità e la morte.

- Il documento più antico a noi noto relativo al primo tentativo di classificazioni delle disabilità è una tavoletta d'argilla babilonese del 2800 a.C. in cui sono identificate tre grandi categorie
  - Mostri per eccesso
  - Mostri per difetto
  - Mostri doppi

Codice di Hammurabi

- Una delle più antiche raccolte di leggi conosciute, il codice promulgato dal re babilonese Hammurabi (regnante dal 1792 al 1750 a.C.), mostra un rapporto complesso con la disabilità. Da un lato, introduce la punizione di varie mutilazioni per specifici reati, creando così disabilità e sottoponendo gli individui disabili a riprovazione e stigmatizzazione collettiva. Dall'altro lato, impone che "il forte non opprima il debole" per coloro che sono diventati disabili accidentalmente.

Il monte Taigeto

Il mondo greco-romano

- Da sempre, gli uomini e le donne hanno messo al mondo bambini non desiderati. Per sbarazzarsene, l'infanticidio fu la pratica più corrente, in particolare nell'Antichità greco-romana dove più documenti attestano il suo carattere legale, soprattutto nel caso di malformazioni. Un'altra soluzione utilizzata fu l'esposizione, ovvero l'abbandono dei neonati indesiderati in un luogo pubblico.

- Ad esempio a Sparta i genitori mostravano il neonato al consiglio degli anziani (la lesché) che valutava se il bambino fosse sano. Se non lo era, veniva ordinato di gettarlo dal monte Taigeto (anche se la veridicità storica di questa pratica viene messa in discussione).

- Ad Atene invece la decisione era lasciata al padre che decideva se tenere il bambino o se esporlo in un luogo remoto, dove sarebbe certamente perito.

Il mondo greco-romano

- Anche a Roma veniva praticato l'infanticidio, con pratiche che variavano nel tempo. Durante la Repubblica (508-30 a.C.), i bambini indesiderati o deformi subivano trattamenti simili a quelli della Grecia. Durante l'Impero (I secolo a.C.), i neonati venivano lasciati presso la Columna Lactaria e poi presi in cura dallo Stato. L'idea che i bambini venissero gettati dalla Rupe Tarpea sembra invece una leggenda, poiché questo luogo, situato vicino al Campidoglio, era riservato ai traditori.

- Alcune persone disabili comunque sopravvivevano. Si sa ad esempio che alcuni uomini senza braccia, gambe, giganti, nani, ermafroditi venivano esibiti nella servitù come divertimento

Il mondo greco-romano

- I primi imperatori cristiani, a partire da Costantino (274-337) e in particolare su impulso dall'educatore di suo figlio, Lattanzio Celio, considerato poi uno dei padri della Chiesa, è sancito lo "ius vivendi" del neonato, senza alcuna eccezione, che decretò l'illegalità di uccidere ed esporre i bambini, nati deformi o meno

- Esporre un bambino non significava ucciderlo, benché molto spesso tale abbandono significasse destinarlo a morte certa. Si trattava di una pratica che aveva alla base una consegna; questi bambini erano rimessi alla volontà delle divinità che stabiliranno il loro destino: morire o continuare a vivere, in quanto ritrovati da altre persone.

Il medioevo

- A partire dal IV secolo d.C. l'infanticidio tende quindi a diminuire come pratica; la religione ha una grande importanza nel quotidiano delle persone e qualunque bambino viene considerato dono di Dio
- In questo periodo appare la nozione di "follia"; questo concetto ingloba tutte le persone "diverse". Di conseguenza la disabilità e la follia vengono confuse
- Il folle è una persona al cui interno c'è una lotta tra Dio e Satana. A dipendenza dal punto dal quale viene vista la lotta, la persona è una persona rispettata (grazie al suo rapporto con Dio) o rigettata (a causa della relazione con il diavolo)

La bandiera della madre folle, XV o XVI sec, Dijon

Si può pensare che molte persone accusate di stregoneria fossero delle persone disabili o con un problema di salute mentale, e certe stramberie o divagazioni venissero considerate come segno del legame con il Diavolo

I primi tentativi di presa a carico

Dall' XI al XIII secolo: i santi guaritori

Il folle partecipava ad un pellegrinaggio volto a far intercedere un santo in favore della sua guarigione

Bruegel il vecchio, Gli storpi, 1568

XII e XIII secolo: le cure mediche

Basate su 2 principi: legare il folle e sottoporlo a trattamenti legati alla luce e all'oscurità

Le cure avvenivano a domicilio, in un monastero o all'ospedale. Gli ospedali in questo momento ospitavano tutti i tipi di persone: pellegrini, vecchi, infermi e folli

Un piccolo numero di folli era rinchiuso nelle prigioni, generalmente a seguito di un delitto; la misura era repressiva e non aveva scopi terapeutici

La grande reclusione (alla fine del Medioevo)

Durante il Medioevo in tutta l'Europa vennero creati dei lebbrosari (lazzaretti), istituzioni economicamente molto importanti per le regioni. Con la fine della diffusione della lebbra (verso la fine del Medioevo) si pose il problema della loro conversione.

Fig. 140. — Une léproserie, miniature d'un ms. du XIIIe siècle. Bibl. de l'Arsenal.

Nell'urgenza di trovare una soluzione, il potere politico decise di riempire i lebbrosari con tutti gli "indesiderati" , creando degli "ospedali generali"

Con la fine del Medioevo, la situazione non cambiò, ma anzi, dopo il 1500 si accentuò con un maggior numero di abbandoni dei bisognosi e avvenne conseguentemente un'espansione delle opere di carità (epoca della "grande reclusione")

L’epoca dei pionieri dell’educazione

- Ritardati ed esclusi cominciarono ad essere oggetto di classificazione per definire chi avesse accesso alle cure mediche e degli ospedali. Essi alla fine del XVIII secolo erano considerati come “incurabili”
- Parlare di vita negli ospedali di fine XVIII secolo era un eufemismo. Le condizioni degli ospedali e degli asili erano più sfavorevoli che mai
- È per questo motivo che alcuni pionieri dell’educazione rifiutarono questa condizione per imporsi in seguito come precursori dell’educazione speciale e in seguito della pedagogia
- Gli scritti di questi innovatori trasformarono la scienza pedagogica dell’epoca (prima parte del XIX secolo)

Philippe Pinel (psichiatra)

Pinel, (1745-1826) nel 1793 decise di lottare contro i maltrattamenti che osservava quotidianamente a Bicêtre ; fece togliere le catene agli “alienati”

È un gesto simbolico che si accompagna a quello che può essere considerato come il primo tentativo terapeutico coerente: il trattamento morale. Questo gesto è conseguenza del considerare anche gli alienati delle persone

Il trattamento morale si basava sui seguenti principi:

- ✓ creazione di un atmosfera calma
- ✓ sorveglianza a carattere umano
- ✓ eliminazione di sanzioni fisiche
- ✓ sospensione degli abusi perpetrati dal personale
- ✓ messa a disposizione di libri e musica
- ✓ implicazione in lavori agricoli

Pinel nell'atto di liberare i pazzi, quadro di Tony Robert-Fleury, Académie de médecine, Parigi, Foto di Giraudon

La scolarizzazione speciale

- La Francia alla fine del XVIII si mostra all'avanguardia nell'educazione in particolare di bambini sordi e ciechi

- 1760 a Parigi apre la prima scuola pubblica per bambini sordi: l'Istituto Nazionale per i Sordo-Muti, gestita dall'Abbé de l'Epée (dove si sviluppò il metodo gestuale come comunicazione per i bambini sordi)

- 1784: Valentin Haüy apre a proprie spese la prima scuola gratuita per giovani ciechi, (Istituto Nazionale dei Giovani Ciechi). Vi verrà formato, prima come studente e poi come insegnante Louis Braille.

- Mancano ancora le classi per bambini con deficit intellettivo. Questo perché mancava la condizione fondamentale: l'identificazione e la definizione del deficit intellettivo. Si dovrà attendere il 1837 perché Séguin fondi una scuola privata per giovani con questo disturbo.

Esquirol – Le prime classificazioni moderne

- Jean-Étienne-Dominique Esquirol fu il primo a stabilire scientificamente una distinzione tra disagio psichico e deficit intellettivo. Nel 1818, lo psichiatra definì per la prima volta la nozione di deficit intellettivo, che chiamò "idiozia". Esquirol identificò l'idiozia come un ritardo dello sviluppo intellettuale di origine organica, osservabile e incurabile, che compromette definitivamente le capacità intellettuali del soggetto.

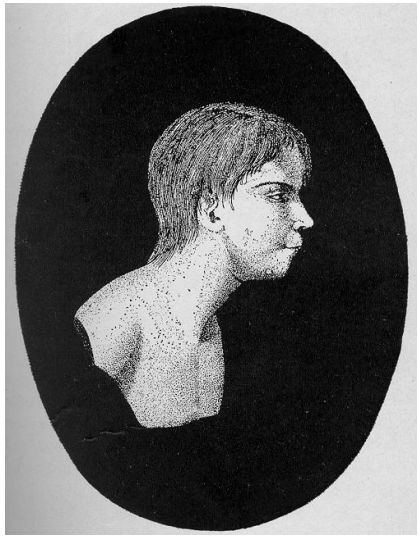
- Al contrario, la demenza era vista come una perdita temporanea o duratura delle facoltà precedentemente presenti.

- Esquirol distinse anche due livelli di deficit intellettivo: l'idiozia e l'imbecillità. La distinzione era basata sull'utilizzo del linguaggio, dove l'idiota aveva la capacità di usare il linguaggio, mentre l'imbecille no.

Jean-Marc Itard e il ragazzo selvaggio

Jean Marc Itard (1774-1834) era un medico e chirurgo francese. Lavorò con Pinel, uno dei maestri della medicina francese. In seguito l'abate Sicard, direttore della Scuola Imperiale dei Sordo-Muti e successore dell'Abbé de l'Epée, lo chiamò come medico-capo dell'istituto.

Nella Francia appena uscita dalla Rivoluzione, nel 1797, nella regione dell'Aveyron venne avvistato in un bosco un "ragazzo selvaggio" che viveva in modo completamente primitivo, nudo, muovendosi come un quadrupede. Catturato una prima volta, riuscì a fuggire, e venne nuovamente preso nel 1800. Il ragazzo non parlava, non aveva alcuna forma di linguaggio ed emetteva solo stridule urla. Ritenuto sordomuto, venne affidato all'abate Sicard che dirigeva all'epoca l'istituto dei sordomuti parigino fondato da de l'Epée.



Jean-Marc Itard e il ragazzo selvaggio

- Vista l'assenza di progressi, Sicard finì per convincersi che il comportamento del ragazzo era sintomo di idiozia (e quindi incurabile).

- L'istituto tuttavia aveva preso un impegno con il governo, e Sicard assunse Itard come medico-capo dell'Istituto allo scopo di educare il ragazzo selvaggio.

- Itard decise di basarsi sulle teorie di Condillac (1714-1780), che sosteneva che un essere umano privato del linguaggio dovesse appoggiarsi sulla percezione sensoriale della realtà tramite la vista, il tatto e l'udito per poter esprimere delle idee o descrivere degli oggetti.

- Secondo Itard il ragazzo non aveva delle tare a livello mentale. Gli mancava semplicemente il linguaggio al fine di acquisire i processi mentali di un essere "normale" e le motivazioni sociali. Questo approccio rompeva con le concezioni dell'epoca sulla pedagogia, fondata sull'insegnamento magistrale

Jean-Marc Itard e il ragazzo selvaggio: i 5 principi educativi

Jean-Marc Itard basò la sua educazione verso il ragazzo selvaggio sui seguenti principi:

1. Attaccarlo alla vita sociali rendendogliela più dolce rispetto a quella che conduceva e soprattutto più analoga a quello che aveva appena abbandonato
2. Risvegliare la sensibilità nervosa tramite le stimolazioni più energiche e a volte per le vive affettazioni dell'animo.
3. Estendere la sfera delle sue idee donandogli dei bisogni nuovi e moltiplicando i rapporti con gli essere che lo circondano
4. Portarlo all'uso della parola, determinando l'esercizio dell'imitazione tramite la legge imperiosa della necessità
5. Esercitare durante un certo periodo, sugli oggetti dei suoi bisogni fisici, le più semplici operazioni dello spirito determinando in seguito l'applicazione su degli oggetti di istruzione

Jean-Marc Itard e il ragazzo selvaggio

- Nel 1801 venne elaborato il primo rapporto di Itard che classificava Victor come un essere inferiore; Itard propose l'ipotesi dell'esistenza di un periodo sensibile per l'apprendimento della parola, al di là del quale non è più possibile acquisire il linguaggio verbale.

- Vi sono diverse critiche possibili al lavoro di Itard; ad esempio il suo focalizzarsi sul linguaggio orale e non propendere per il linguaggio gestuale, o il non essere partito dalle capacità presenti presso il ragazzo

- È comunque più interessante concentrarsi sulle eredità lasciateci da questa esperienza

Jean-Marc Itard e il ragazzo selvaggio

È da questa relazione tra una mente illuminata e un “ragazzo selvaggio” che nasce l’educazione speciale moderna.

Oggigiorno, riconosciamo ad Itard l’ideazione di molte pratiche educative quali la diagnosi funzionale dell’udito, lo sviluppo del metodo orale per bambini con disturbi d’udito, l’imitazione come tecnica educativa, la generalizzazione degli apprendimenti

Da leggere entro settimana prossima

- Matteo Schianchi, 2016, Storia della disabilità, pp.180-184 Educare i disabili intellettivi